EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94316
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2024-10-07 12:33:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARLOS HECTOR AVILA PARADA			RUN	: 4.389.538-9
F.Nac	: 17-06-1945	Edad	: 79 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: FUNDO BUEN RETIRO			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 998024691		
Fecha Ingreso	: 2024-09-28	Fecha Egreso	: 2024-10-07 12:33:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D63.0-ANEMIA EN ENFERMEDAD NEOPLASICA (C00- D48+)

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Obstrucción intestinal
2. SX anémico en estudio
3. ERC Reagudizada
4. CA recto en QMT neoadyuvante
5. Doble J por hidroureteronefrosis obstructiva
6. HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. D46.4-ANEMIA REFRACTARIA, SIN OTRA ESPECIFICACION (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Contexto de hospitalización de paciente impresiona: se realiza hallazgo previo QMT de anemia (6.9) por lo que es derivado a servicio de urgencias únicamente para transfundir hasta alcanzar prerrequisito (8-9Hb en contexto de terapia QMT).
Ingresa y se evidencia ERC reagudizada (Crea basal 1.7 actual de 3.4) por lo que se decide hospitalizar más alla de transfundir 1 UD alcanzando Hb de 8.8.
Historia supone hipoalimentación desde hace +1 semana previo ingreso, asociado nauseas y vómitos. Además, con ausencia de deposiciones hace 4-5 días previo ingreso a través de ileostomía. Sin gases hace 3+ días previo ingreso
Durante estancia inicia con vómitos de contenido porráceo, por lo que se decide colocar sonda a caída libre con contenido+++, además de tomar TC AP que reporta:
TC AP CC 30/09/24
Oclusión intestinal con cambio de calibre en flanco derecho
UHN bilateral con pigtal doble J derecho. Quistes renales simples. Colelitiasis. HPB. Diverticulo vesical.
Valorado por CX en primera instancia quien reafirma regimen cero. Posterior 48h se valora nuevamente donde se descarta cuadro obstructivo, mencionando realimentación temprana.
Antecedentes de paciente incluyen toma de opiáceos (en contexto de dolor CA), además de fierro VO por anemia crónica secundaria.
Se reinicia alimentación sin conflicto.
Durante estancia paciente persiste SIN deposiciones. Se conversa caso con Jefatura de Servicio de Cirugía, Dra. Spano, quien considera que no se trata de cuadro obstructivo y que se debe favorecer tránsito intestinal. Se realiza TC control:
TC AP CC 05/10/24
Dilatación del sistema excretor derecho con cateter doble J bien posicionado. Signos de nefropatía crónica izquierda. Colelitiasis

En vista de estabilidad se indica seguimiento en domicilio HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen: segun indicaciones nutrición. Favorecer probióticos
2. Omeprazol 20mg vo dia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV: dos dosis EV (12/14)
4. Metronidazol 500mg vo c8h (8/10)
5. Escitalopram 10mg vo dia

6. Quetiapina 25mg vo dia
7. Lactulosa 10cc c8h SOS
8. Amlodipino 5mg vo c12h
9. Control SU SOS en caso de persistencia de NO deposiciones
10. Avisar eventualidad

EXÁMENES Y RESULTADOS

TC AP CC 05/10/24
Dilatación del sistema excretor derecho con cateter doble J bien posicionado. Signos de nefropatía crónica izquierda. Colelitiasis
TC AP CC 30/09/24
Oclusión intestinal con cambio de calibre en flanco derecho
UHN bilateral con pigtal doble J derecho. Quistes renales simples. Colelitiasis. HPB. Diverticulo vesical.

04/10/24
Creat 1.8 PCR 36.2 Uremia 70 leuc 3300 Hb 8.6 hto 25.9 plaq 298000

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO